

pr Samlani 1

(0:05 - 1:25)

Bonjour tout le monde, donc je suis contente de vous voir virtuellement aujourd'hui pour discuter un petit peu des différents cours qu'on a fait en pathologie digestive. Donc aujourd'hui l'objectif sera surtout de voir les choses qui vous dérangent le plus. Je vous ai préparé une petite série de QCM et je compte surtout sur le fait que vous posiez des questions puisque nous ferons d'autres séances d'interaction où on ira plus profondément donc dans les cours et dans vos, ce que j'appellerai vos lacunes ou vos questions.

Donc on a fait, on a presque fini le programme, mon programme de pathologie digestive avec vous et les différents cours que nous avons fait cette année-là, donc ce sont les cours relatifs à la dyspepsie, au gastrite, nous avons fait les parasitose, nous avons fait les pancréatiques, la tuberculose et nous avons fait aussi l'hypertension portale et la cirrhose. Donc je commencerai par vous poser quelques QCM qu'on a vu, qu'on voit tous les ans et je voudrais donc que vous me donniez votre ressenti concernant ces QCM. Donc hier je vous ai mis l'hypertension portale et la cirrhose, donc on commencera par ces deux cours.

(1:27 - 4:44)

Parmi les étiologies de la cirrhose hépatique, on retrouve une hépatite virale A, une hépatite auto-immune, une maladie cholestatique chronique, une hépatopathie alcoolique, une maladie métabolique. Qu'est-ce que vous retenir des étiologies de la cirrhose et qu'est-ce que vous retenir dans le titre aussi si vous avez vu en fait mon cours d'hier parce que je vous ai mis un petit un petit couac dans le titre de cette question. Quelles sont les étiologies de la cirrhose les plus fréquentes ? Alors deuxième question, une cirrhose du foie, là aussi même couac, peut se compliquer de 1 hémorragie ? Oui, oui j'ai des réponses.

Donc les étiologies de la cirrhose, on a l'hépatite A, vous avez dit l'hépatite auto-immune, hépatite A, hépatite auto-immune, maladie cholestatique chronique et hépatopathie alcoolique. Là et là, hépatite auto-immune, maladie cholestatique chronique, hépatopathie alcoolique, maladie métabolique. C'est la bonne réponse.

Donc la cirrhose du foie, je vous l'ai mis hier sur la plateforme, c'est une, c'est un stade ultime de nombreuses hépatopathies chroniques, c'est à dire que ce sont des hépatopathies qui vont évoluer vers des hépatopathies chroniques et qui vont par des mécanismes inflammatoires aigus, puis chroniques, entraîner des dépôts, donc de collagène et une fibrogénèse qui est accrue et il y aura de la fibrose au niveau du foie. Donc les causes responsables, donc basiquement ça sera des hépatopathies chroniques. Or l'hépatite virale A, je sais que vous avez fait le cours, est-ce que l'hépatite A donne une hépatopathie chronique ? Voilà, exactement.

Donc l'hépatite A, c'est surtout un problème qui est aigu et donc c'est un problème qui va, elle va,

oui, elle va occasionner, l'hépatite A va occasionner une souffrance hépatique, hépatocytaire aiguë. Elles peuvent se manifester à des degrés variables par de l'insuffisance hépatocellulaire. Elle peut entraîner ce qu'on appelle l'hépatite fulminante.

(4:46 - 5:06)

Mais en aucun cas, elle n'évoluera vers de la fibrose. Donc les étiologies, on enlève l'hépatite A, on reste sur l'hépatite auto-immune parce que l'hépatite auto-immune peut être aiguë comme elle peut être chronique. Une maladie cholestatique chronique, une maladie cholestatique chronique, ce sont des maladies qui altèrent les canaux et les canalicubilières à des degrés variables.

(5:08 - 7:30)

L'hépatopathie alcoolique, elle peut être responsable d'une hépatite aiguë comme, si, elle peut être responsable d'une hépatite aiguë comme d'une hépatite chronique. Et les maladies métaboliques, ça vous ne l'avez pas encore vu mais vous l'aurez pour demain, les maladies métaboliques, quand il y a une surcharge du foie au cours de certaines maladies de surcharge au cours de l'hémochromatose, la maladie de Wilson, il peut y avoir des phénomènes inflammatoires aigus puis des phénomènes inflammatoires chroniques et ça peut évoluer vers la cirrhose. Donc, toutes les réponses sont bonnes sauf l'hépatite a. Après, il y a la deuxième question.

Une cirrhose peut se compliquer de hémorragie digestive, cancer du foie, décompensation acétique, insuffisance rénale, troubles endocriniens. Alors, comme je vous ai dit, il y a deux trucs au niveau du titre. Je vous ai dit dans le cours qui est sur la plateforme qu'on ne parle pas, ne parle plus de cirrhose du foie parce qu'il n'y a pas d'autre cirrhose.

On parlera de cirrhose simple. La cirrhose peut se compliquer d'hémorragie digestive. Est-ce que c'est vrai ou pas? A, B, C, E. Alors, elle se complique d'hémorragie digestive par un mécanisme qui est l'hypertension portale.

Pourquoi? Parce que la cirrhose est une cause intra-hépatique de l'hypertension portale. Vous allez voir dans le cours, si vous avez eu le temps de le voir hier, que l'hypertension portale, c'est une augmentation du gradient de la pression au niveau du système porte. Et la cause la plus fréquente, c'est la cirrhose qui sera responsable d'une augmentation de pression et qui dit augmentation de pression, va dire ouverture de certaines voies collatérales pour tenter de diminuer cette pression, tenter de court-circuiter le système porte.

C'est ce qu'on appelle une circulation collatérale ou des anastomoses portosystémiques qui vont s'ouvrir. Et parmi celles-ci, en haut, vous allez voir sur le cours, si vous avez eu le temps de le voir, il y a l'ouverture de certaines voies anastomotiques responsables de présence de varices oesophagiennes. Et ces varices oesophagiennes, vous avez fait ça dans le cours d'hémorragie digestive de sémiologie, elles peuvent se compliquer de rupture, entraîner une hémorragie

digestive haute à type d'hématémèse ou bien de méléna.

(7:31 - 7:50)

Il peut y avoir également une ouverture de circulation collatérale basse avec apparition de varices rectales. Dans ce cas-là, ce qu'il y a, ce sont des rectoagies par rupture de ce varice rectal. Après, est-ce qu'une cirrhose peut se compliquer de cancer du foie ? Un peu de réflexion, vous n'avez même pas besoin de voir le cours.

(7:50 - 8:12)

Qui dit cirrhose dit phénomène inflammatoire aigu chronique puis fibrose. Par quel mécanisme est-ce qu'elle va se compliquer de cancer du foie ? Parce que dans le temps, il y a apparition de phénomènes exactement de carcinome pathocellulaire. Mais avant le carcinome pathocellulaire, c'est un phénomène qui va durer sur de nombreuses années.

(8:12 - 8:22)

Il y a de la métaplasie et de la dysplasie. Il y a des phénomènes de transformation. Et à terme, il peut y avoir apparition d'un carcinome pathocellulaire.

(8:23 - 8:47)

Et comment est-ce qu'on peut dépister ce carcinome pathocellulaire ? C'est par un examen qui est anodin, qu'on réalise à chaque fois qu'on est face à un cirrhotique. C'est l'échographie qu'on fera à quel rythme ? Allez-y. À quel rythme on fait une échographie chez un cirrhotique ? C'est une échographie qu'on fera tous les semestres, tous les 6 mois.

(8:47 - 9:05)

Donc on réalise une échographie abdominale tous les 6 mois à la recherche de l'apparition d'un nouveau nodule. Pourquoi 6 mois ? Parce que c'est le temps que le nodule peut prendre pour doubler de taille. Et comme vous allez voir ça en pathologie, la taille des nodules est très importante parce qu'elle permet un traitement curatif.

(9:06 - 9:21)

Donc quand c'est des petits nodules inférieurs à 3 cm, quand il y en a 3, inférieurs à 3 cm, un traitement curatif est encore possible. Quand les nodules sont très gros, un traitement curatif n'est plus possible, le risque de métastase n'est plus important. Donc au cours de la cirrhose, c'est une condition très cancéreuse, il faut s'en rappeler.

(9:22 - 9:37)

Il faut toujours réaliser des échographies tous les 6 mois. Alors, est-ce que la cirrhose peut se

complicuer de décompensation acétique ? Je vous ai mis une très jolie diapositive dans le cours pour vous donner la physiopathologie. C'est au cours de l'hypertension portale.

(9:37 - 10:00)

Au cours de l'hypertension portale, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des phénomènes qui vont... la sécrétion de substances vasodilatatrices pour tenter de diminuer la pression portale. Ces substances vasodilatatrices vont diminuer le débit entre les mypotentions. Et le rein va réagir par le système que vous connaissez, rénine-angiotensine-aldostérone, pour augmenter la tension artérielle.

(10:01 - 10:12)

Et il va entraîner une absorption d'eau et d'électrolyte à un certain moment. Il va y avoir donc un déséquilibre et il y aura de l'acide. Et cet acide, effectivement, peut se surinfecter.

(10:12 - 10:21)

C'est une complication qui est très grave au cours de la cirrhose, la surinfection liquide d'acide. Et le diagnostic, on le pose. Vous avez vu ça, je pense, dans la sémiologie d'acide.

(10:22 - 10:35)

On le pose. Comment le diagnostic d'acide surinfecté ? Cliniquement, ce sont des patients qui peuvent avoir des douleurs abdominales, de la fièvre, des douleurs abdominales, de la diarrhée. Et il faudra faire une ponction d'acide.

(10:35 - 10:51)

Et on parle d'acide surinfecté quand le taux de polynucléaire neutrophile est supérieur à combien ? C'est quoi le taux ? Vous avez vu ça dans le cours de sémiologie. On parle d'acide surinfecté quand le taux de polynucléaire neutrophile est supérieur à 250. Vous avez tout à fait raison.

(10:53 - 11:05)

Voilà. Donc, autre décompensation, autre plutôt complication, l'insuffisance rénale. Est-ce que la cirrhose du foie, la cirrhose peut se compliquer d'insuffisance rénale ? Oui ou non ? Oui.

(11:05 - 11:14)

Donc, on a parlé. Quand je viens de le dire, au cours de l'hypertension portale, le rein est sollicité. C'est-à-dire qu'il y a une hypertension.

(11:15 - 11:30)

Et donc, on tentera de la diminuer par des substances vasodilatatrices. Et le rein va réagir pour

augmenter exactement la tension artérielle, le débit. Et à force d'être sollicité, ce rein va se fatiguer.

(11:30 - 11:42)

Et quand il va se fatiguer, il va entraîner une insuffisance rénale liée à l'hypertension portale hépatopathique, qu'on appelle syndrome hépatorénal. C'est ce qu'on appelle le syndrome hépatorénal. Dernière question.

(11:43 - 11:59)

Est-ce qu'on peut trouver des troubles endocriniens au cours de la cirrhose ? Ça, à partir de la physiopathologie, en principe, vous devez le comprendre. Est-ce qu'on peut trouver des troubles endocriniens dans la cirrhose ? Oui. Par quel mécanisme ? Marwa, par quel mécanisme ? Exactement.

(11:59 - 12:10)

Basiquement, c'est bête. C'est l'insuffisance hépatocellulaire. Quand vous avez un cirrhotique qui est en insuffisance hépatocellulaire, il fera beaucoup de complications liées à l'insuffisance hépatocellulaire et parmi celles-ci, les troubles endocriniens.

(12:11 - 12:21)

Et donc, dans le cours de la cirrhose, je vous ai mis ça. Vous avez parlé du fonctionnement du foie. Je vous ai mis en fait qu'il y a deux stades au cours de la cirrhose.

(12:21 - 12:34)

Un stade où la cirrhose est compensée et un stade où la cirrhose est décompensée. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des cirrhotiques qui peuvent être pendant 10 ans, 15 ans. Ils ont une hépatopathie chronique, mais ils sont bien.

(12:34 - 12:38)

Ils sont comme nous. Ils marchent, ils montent les escaliers et tout va bien. Puis un jour, il y a la décompensation.

(12:39 - 13:27)

Et la décompensation va se manifester par les complications, par l'insuffisance hépatocellulaire. Et parmi celles-ci, l'insuffisance hépatocellulaire, celui qui est le plus marquant, le plus parlant, c'est l'asthémie, avec toutes les autres complications liées à l'insuffisance hépatocellulaire et par les complications d'hypertension portale. Donc, ceci pour... Alors, dans le cours de la cirrhose, je vous ai mis en fait l'évaluation pronostique.

(13:28 - 13:44)

Parmi les éléments de l'évaluation pronostique, on peut évaluer simplement... Si un patient est bon bien compensé, voilà, on dit que le pronostic est bon. Sinon, il y a deux scores qu'on utilise le plus fréquemment. C'est le score de Child PUG et le score de MEND.

(13:45 - 14:02)

Donc, le score de Child PUG, c'est le score que vous voyez dans les services où vous faites vos stages. C'est un score qui a une particularité parce qu'il regroupe plusieurs items qui sont cliniques, qui sont biologiques. Et parmi ces items, donc, il regroupe des paramètres cliniques et biologiques.

(14:03 - 14:22)

Et donc, vous pourrez répondre à partir de ce que je viens de dire facilement à cette QCM. Le score de Child PUG regroupe des paramètres cliniques et biologiques, des paramètres cliniques seulement, un intérêt pronostique mesuré en points et permet de suivre la cirrhose du foin. Alors oui, il regroupe des paramètres cliniques et biologiques.

(14:22 - 14:35)

Vous allez les voir, en fait, il y a l'encéphalopathie hépatique, il y a l'acide et puis des paramètres biologiques. Vous avez la bilirubine, l'albumine et vous avez le TP. Il y a un intérêt pronostique, oui.

(14:35 - 14:58)

Oui, il y a un intérêt pronostique parce que des Childs qui sont très évolués sont indicateurs que ça ne va pas très bien pour le patient. Il est mesuré en points et il peut permettre le suivi d'une cirrhose. Et vous allez voir ça quand vous aurez des malades ou si vous avez des malades parce que dans les dossiers d'hépatos, vous avez des malades qui sont prises en charge.

(14:58 - 15:12)

On peut assécher l'acide, on peut agir au niveau de l'encéphalopathie et ils peuvent passer de stades qui sont très évolués à des stades qui ne sont pas. Donc, c'est un score qui est intéressant et c'est ce que vous voyez ici. Il est bon pour l'évaluation pronostique, le score de Child Pug.

(15:12 - 15:25)

Vous avez l'encéphalopathie, l'acide, la bilirubine, l'albumine, le taux de protrombine. Vous avez des Child A. On dit que le patient est classé Child A quand on est entre 5 et 6 points. Child B

entre 7 et 9 points et Child C entre 10 et 15 points.

(15:25 - 15:38)

Et on peut passer bien sûr d'un Child C à un Child B. Inversement, dans la vie, ça peut se compliquer. Un Child B qui peut évoluer vers un Child C. Alors, je reviens vers les premiers cours. Vous vous rappelez des gastrites.

(15:39 - 15:53)

Donc, on avait fait des gastrites et je vous avais dit qu'il y avait des gastrites aiguës et des gastrites chroniques là aussi. Et parmi les étiologies des gastrites aiguës, pardon, des gastrites chroniques, on avait la gastrite *helicobacter pylori*. Vous vous en rappelez bien.

(15:54 - 16:12)

Vous avez la gastrite auto-immune. Et là, c'est une question qui est extrêmement simple à partir de laquelle on pourra réaliser un petit peu. La gastrite auto-immune est plus fréquente chez la femme jeune, vrai ou faux? A, B, C, D. Non, vrai, faux.

(16:13 - 16:23)

Je préfère que vous me disiez vrai ou faux, comme ça on peut discuter un petit peu. Alors, plus fréquente chez la femme jeune, non. La gastrite auto-immune est plus fréquente chez la femme d'âge mûr.

(16:23 - 16:44)

On ne la retrouvera pas chez des jeunes femmes de 18 ans, de 20 ans, mais plus chez des femmes d'âge mûr, d'âge moyen. Elle est souvent associée à d'autres maladies auto-immunes, vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Elle est souvent associée à des maladies auto-immunes.

(16:44 - 17:03)

D'ailleurs, quand vous tombez, quand on fait une fibroscopie et qu'on trouve des éléments en faveur d'une gastrite auto-immune, on recherche des maladies auto-immunes. Ça va du diabète type 1 à une pathologie thyroïdienne, un vitiligo. On traque ces pathologies auto-immunes.

(17:04 - 17:18)

Elle est souvent asymptomatique au début, vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est vrai. Souvent, elle est asymptomatique au début. Elle n'est pas très criante.

(17:18 - 17:51)

Elle peut être associée à des signes neurologiques? Elle est quelle? Elle peut être associée à

des signes neurologiques? Vrai. Par déficit en vitamine B12, parce qu'il y a une altération au niveau de la partie fundique, donc une diminution de la sécrétion de facteurs intrinsèques, qui est nécessaire à l'absorption de la vitamine B12. Donc, il y aura une diminution de la vitamine B12 et ça va se manifester par une sclérose combinée de la moelle.

(17:52 - 18:17)

Elle n'évolue jamais vers un cancer gastrique. Est-ce que c'est une gastrite qui est atrophiante? Oui ou non? Est-ce qu'elle peut évoluer vers un cancer gastrique ou pas? Oui. Exact.

(18:17 - 18:25)

Donc là, je sors le cours. Comme ça, je vois ce que je vous ai dit. Dans le cours, je vous ai dit que les gastrites chroniques peuvent être atrophiantes ou non-atrophiantes.

(18:25 - 18:45)

Les atrophiantes évoluent vers le cancer. Les plus fréquentes, c'est la gastrite *helicobacter pylori*, qui est très fréquente, 20 à 50 %, et dont le mécanisme est une contamination oro-orale ou péco-orale durant l'enfance. Et je vous ai dit que je la cherche.

(18:45 - 19:01)

La gastrite auto-immune, je vous l'ai dit texto, c'est souvent chez la femme de plus de 50 ans. Elle est souvent limitée au corps avec présence d'un filtre à lymphoplasmosithère. Dans un contexte d'auto-immunité, diabète, thyroïdite, vitiligo, *helicobacter pylori* n'est pas responsable.

(19:01 - 19:15)

Asymptomatique au début. Il peut y avoir des signes neurologiques secondaires à un déficit d'absorption de vitamine B12. Elle peut se manifester par une anémie macrocytaire à régénérative pernicieuse, par une glossite, par des signes neurologiques.

(19:16 - 19:27)

Et puis, le diagnostic est fait par la recherche d'anticorps, anticelluloparité, antifacteurs intrinsèques. Et le risque, c'est qu'elle évolue vers des tumeurs carcinoïdes fundiques. Ce sont des tumeurs neuro-endocrines.

(19:28 - 19:40)

Et le risque d'adénocarcinome gastrique est important également. Donc, c'est une gastrite qui est atrophiante avec risque d'évolution vers un cancer. Donc, pour les chapitres gastrite, je pense que c'est bon.

(19:41 - 19:51)

Il y a tout de même un petit rappel pour les gastrites *helicobacter pylori*. J'aimerais bien que vous vous en rappeliez. C'est qu'elles sont fréquentes.

(19:51 - 20:08)

C'est la contamination oro-oral, phéco-oral. Il peut y avoir des gastrites *helicobacter pylori* aiguës, puis elles évoluent vers la forme chronique. Et qu'en l'absence de lésions ulcéreuses ou tumorales associées, on peut très bien avoir une gastrite chronique *helicobacter pylori* et être totalement asymptomatique.

(20:09 - 20:23)

Sinon, parfois, on peut avoir, au cours d'une gastrite par *helicobacter pylori*, des troubles dyspeptiques ou une gastroparesie. Et le traitement reposera bien sûr sur l'éradication. On passe au chapitre pancréasite chronique.

(20:24 - 20:41)

Et ça, ce sont les complications des pseudokistes. Alors, la question que je vais vous poser d'abord, est-ce qu'un pseudokiste est un vrai kyste ? Est-ce qu'il a une paroi ou pas ? Est-ce qu'un pseudo... En fait, la réponse est dans la question. Est-ce qu'un pseudokiste... Non.

(20:42 - 21:08)

Un pseudokiste est un pseudokiste. C'est-à-dire qu'il peut s'agir d'une formation qui s'apparente à un kyste, mais qui est juste de la rétention de la sécrétion pancréatique, c'est-à-dire la sécrétion pancréatique qui est collectée. Comme il peut y avoir un pseudokiste qui contient de la nécrose, c'est-à-dire qu'au cours du processus de la pancréatite chronique, il y a des poussées de pancréatite aiguë, et il y a de la nécrose qui a coulé, elle s'est collectée.

(21:08 - 21:28)

Et dans ce cas-là, un gros kyste, est-ce qu'il peut donner de la compression ? Est-ce qu'il peut comprimer quelque chose ? Est-ce qu'un pseudokiste au cours d'une pancréatite chronique peut se compliquer de compression ? Oui. Parce qu'imaginez un petit peu la chose. C'est dommage qu'on ne se voit pas, mais imaginez un petit peu la chose.

(21:29 - 21:44)

Vous avez une grosse collection, elle peut comprimer dans l'abdomen, elle peut comprimer tout ce qu'elle veut. Elle peut comprimer la voie biliaire entraînée à Nictér, elle peut comprimer le diodényme et entraîner des douleurs et des choses comme ça. Elle peut comprimer tout et

n'importe quoi.

(21:46 - 22:22)

Je vais vous voir ce que je vous ai mis dans le cours. Alors, bien sûr, c'est une collection liquidienne qui est organisée, qui peut être en intra- ou extra-pancréatique, parce qu'il y a les kystes rétentionnels en fait, c'est de la sécrétion, c'est du suc pancréatique, et il y a de la nécrose, qui n'a pas d'épithélium propre, et qui peut comprimer les organes de voisinage, la voie biliaire principale, le diodényme, ou bien même comprimer la veine porte, et dans ce cas-là, entraîner une hypertension portale. Parmi les complications des pseudokistes, est-ce que les pseudokistes peuvent évoluer vers un cancer ? Là aussi, la réponse est dans la question.

(22:22 - 22:52)

Un pseudokiste, c'est une collection de nécrose et de suc pancréatique. Est-ce qu'il peut évoluer vers un cancer ? Un pseudokiste ne peut pas évoluer vers un cancer. Non, il ne peut pas évoluer vers un cancer.

(22:54 - 23:21)

La pancréatite chronique, parce que là aussi, la pancréatite chronique, ce sont des lésions inflammatoires qui vont évoluer vers la chronicité, qui vont entraîner une déformation architecturale, une destruction des canaux, il va y avoir de la fibrose, il va y avoir de la métaplasie, de la dysplasie. Le parenchyme pancréatique peut être siège d'un cancer, mais le pseudokiste en lui-même, non. Le pseudokiste, c'est une grosse boule, c'est comme une orange qui est pleine.

(23:21 - 23:43)

Elle peut comprimer, elle peut se rompre, elle peut s'infecter et elle peut saigner. Elle peut comprimer quelque chose, imaginez, c'est une grosse orange qui est pleine de liquide, elle peut comprimer, elle peut se rompre, s'écraser, ça c'est un problème, elle peut s'infecter parce qu'il y a de la nécrose dedans et des choses, et elle peut saigner. Mais elle n'évoluera pas vers un cancer.

(23:43 - 23:57)

Le parenchyme en lui-même va peu évoluer vers un cancer, pas le pseudokiste. Donc, on oublie les pancréatiques chroniques et on passe à la dyspepsie. Donc, gastrite et dyspepsie.

(23:57 - 24:09)

Les six cliniques imposant la réalisation d'une endoscopie au cas de la dyspepsie sont A, un amaigrissement important. B, une hémorragie digestive. Surveillance... Attendez, attendez, je

m'arrête.

(24:09 - 24:15)

Je reviens et je m'arrête. Surveillance du pseudokiste. Alors, le pseudokiste, quand on a des pseudokistes, bien sûr qu'on surveille.

(24:15 - 24:35)

Quand vous avez des patients qui ont des pancréatites chroniques, si vous les voyez, c'est qu'ils ont des complications. Alors, dans le cours d'un pancréatite chronique, je vous ai dit que, et revoyez-le, que ça passe par des phases. Il y a la première phase, parce que l'éthiologie la plus fréquente, c'est quoi, pour la pancréatite chronique ? L'éthiologie la plus fréquente, c'est l'alcool.

(24:35 - 24:44)

Après, il y a les autres étiologies. Dans la première phase, les premières années, la symptomatologie est très brillante. C'est la douleur qui parle.

(24:44 - 25:08)

Après, ce sont les complications, c'est-à-dire la présence de pseudokistes et les complications des pseudokistes. Après, dans la dernière phase, c'est les syndromes déficitaires, l'insuffisance pancréatique, exocrine et endocrine. Alors, quand un patient vous voit pour une poussée de pancréatite aiguë, sur pancréatite chronique, parce qu'un patient qui a une pancréatite chronique, il peut être stable pendant des mois, des années, dans la deuxième phase.

(25:08 - 25:17)

Puis, un jour, il reconsume de l'alcool. Je donne le modèle d'alcool, parce que c'est le plus fréquent. Quand il reconsume de l'alcool, il peut faire une poussée aiguë sur pancréatite chronique.

(25:18 - 25:34)

Et il peut faire des complications. Vous, vous allez l'examiner, vous allez lui faire les imageries qu'il faut, échographie abdominale, TDM abdominal, peut-être IRM, écho-endoscopie. Et si vous tombez sur des pseudokistes, il va falloir discuter, parce que tout dépendra de la taille des pseudokistes et de ce qu'ils contiennent.

(25:35 - 25:52)

Si ce sont des gros pseudokistes, votre patient sera symptomatique. Il aura de la douleur, de la compression, et il aura peut-être de l'ictère, et ça va le déranger. Et ça va imposer un traitement, soit endoscopique, un drainage de pseudokistes, qui se fera sous écho-endoscopie, soit

chirurgical.

(25:53 - 26:08)

Donc, évidemment, vous serez obligés de surveiller ces pseudokistes pour qu'ils ne se compliquent pas. Mais quand ce sont des pseudokistes qui sont petits, vous vous dites que peut-être c'est rétionnaire, c'est juste de la rétention. Et dans ce cas-là, vous n'allez pas intervenir et vous allez surveiller votre patient.

(26:08 - 26:24)

Et au cours des imageries que vous allez faire, vous allez voir la diminution du pseudokiste ou bien l'augmentation du pseudokiste. Dans ce cas-là, on passe à un traitement pour soulager le patient. OK ? Donc, on revient à la dyspepsie.

(26:25 - 26:44)

Alors, vous vous rappelez de la dyspepsie ? Je vous avais donné une définition qui n'est pas à moi, mais qui est en fait une définition de la littérature. C'est comme ça qu'on définit une dyspepsie. Une dyspepsie vient du mot grec dyspepsia qui est difficulté à digérer.

(26:45 - 27:00)

C'est un motif qui est extrêmement fréquent. Et elle est définie comme étant un ensemble de symptômes, une douleur ou un inconfort chronique récidivant de la région épigastrique provenant du tube digestif supérieur. Parfois, une douleur épigastrique, un type de brûlure ou de crampes.

(27:01 - 27:18)

Parfois, un ballonnement d'épigastre, une digestion lente ou une satiété précoce. Donc, c'est pour ça qu'il faut se rappeler la source ou l'étymologie dyspepsie, difficulté à digérer. Donc, ça peut se manifester par une douleur épigastrique, un ballonnement, une digestion lente ou une satiété précoce.

(27:19 - 27:49)

Alors, en principe, quand quelqu'un est jeune, bien portant, qui n'a pas perdu de poids, on peut dire que ces dyspepsies-là, voilà, qu'on peut la surveiller. Mais quand est-ce qu'on doit réaliser une endoscopie digestive au cours d'une dyspepsie ? Au cours d'un amaigrissement important. Si quelqu'un maigrit beaucoup, est-ce que vous allez faire une endoscopie ? Oui ou non ? Une hémorragie digestive ? Vous faites une endoscopie.

(27:50 - 28:00)

Dyspepsie plus hémorragie digestive. Un trouble à déglutition, c'est-à-dire une dysphagie, ou

bien une audinophagie. Vous savez la différence.

(28:00 - 28:06)

La dysphagie, c'est quand j'ai du mal à avaler. Ça bloque. L'audinophagie, c'est quand j'avale, mais ça fait mal pendant la déglutition.

(28:08 - 28:30)

L'âge avancé, 75 ans, 80 ans et dyspepsie, est-ce que vous faites une fibroscopie ? Une année et demie et dyspepsie, est-ce que vous faites une fibroscopie ? Oui. Donc, en fait, tous les items sont vrais. Pourquoi ? Parce qu'une dyspepsie, ça peut être secondaire.

(28:31 - 28:38)

Je vais vous montrer ça. Ça peut être secondaire, en fait, à une cause qui est fonctionnelle. Il y a dyspepsie fonctionnelle, il y a dyspepsie organique.

(28:38 - 29:07)

Et quand il y a dyspepsie organique, qu'est-ce qu'on craint le plus ? On craint le cancer. Alors, pourquoi est-ce qu'on traite une dyspepsie pseudo-ulcéreuse par IPP en premier ? Une dyspepsie fonctionnelle, on la traite par IPP en premier. Est-ce que ça ne va pas aggraver la dyspepsie puisque le sucre ne sera pas assez acide pour digérer le contenu gastrique ? C'est une dyspepsie pseudo-ulcéreuse.

(29:08 - 29:18)

C'est une dyspepsie pseudo-ulcéreuse. On la traitera par IPP en premier parce que le symptôme que vous rapporte le patient, c'est cette douleur. Donc, c'est pour ça que vous donnez des IPP.

(29:19 - 29:29)

Son problème à lui ne sera pas une gastroparesie ou une difficulté à évacuer son estomac. Dans ce deuxième cas de figure, on peut donner, bien sûr, des prokinétiques. Donc, votre réponse est dans votre question.

(29:30 - 30:00)

Pourquoi est-ce qu'on traite une dyspepsie pseudo-ulcéreuse par IPP ? Parce que le symptôme, le maître symptôme qui appelle, surtout quand elle est fonctionnelle, c'est la douleur. Dans ce cas-là, vous soulagez le patient par IPP. Vous avez compris ? Donc, tous les items sont vrais.

(30:01 - 30:33)

Là, parce que ce qu'il faut se rappeler en tête, on l'explique, mais on ne l'explique pas assez,

c'est qu'il faut scinder ce qui est fonctionnel de ce qui est organique. S'il y a réellement un ulcère, même si je donne des IPP, et j'aurai tort de donner des IPP parce qu'il faudra explorer, faire des biopsies, rechercher une gastrite et un mycobacter pylori, si c'est un ulcère gastrique, faire des biopsies pour éliminer un cancer. Dans ce cas-là, les IPP ne sont pas indiqués, c'est le traitement de l'étiologie qui est indiqué.

(30:33 - 31:09)

Quand c'est une dyspepsie qui est fonctionnelle, et qu'on sait qu'il n'y a rien, mais c'est juste qu'il y a des signes d'appel qui sont pseudo-ulcéreux, là aussi c'est comme pseudo-kyste, dans ce cas-là, exactement, il est capable de digérer, c'est juste la douleur qui le gêne, et qui n'arrive pas, cette douleur-là ne lui donne pas la possibilité de manger correctement, il se retient, parce que son estomac est endolori. Donc, dans ce cas-là, ce sera un traitement qui est symptomatique. Donc, ce qu'on craint le plus, comme je vous ai dit, c'est ce qui est organique, ce qui est cancéreux.

(31:10 - 31:49)

La douleur peut être la conséquence des deux, soit la distension, parce que l'estomac ne se distend pas assez, c'est pas $A + B = C$, c'est $A + B < C$, vous savez, entre parenthèses, plus D plus E, donne quelque chose. C'est-à-dire que la douleur, elle peut être secondaire à la distension, et pourquoi est-ce que, parce que l'estomac ne se distend pas assez, parce qu'il n'y a pas assez de compliance, mais la douleur peut être secondaire et à la distension, et à une hypersensibilité de l'estomac. C'est-à-dire que cet estomac et la muqueuse sont hypersensibles à la sécrétion acide, et en même temps, ça c'est pour la fonctionnelle, alors en même temps, il y a une difficulté de distension.

(31:49 - 32:44)

Ça peut être l'un ou l'autre, c'est pour ça que dans le premier cas de figure, c'est une dyspepsie pseudo-ulcéreuse, dans l'autre, c'est des crampes, c'est une satiété précoce, et on traite, quand c'est une dyspepsie fonctionnelle, on traitera en fonction du type de douleur, parfois par des IPP, parfois par des IPP en association avec des prokinétiques, et parfois même, je vous l'ai mis dans le cours, je pense, par un traitement psychologique, quand il n'y a pas d'explication particulière. Donc ce qu'on craint, surtout ce qui est organique, pour revenir à ça, c'est le cancer, les signes du cancer, l'hémorragie digestive, un cancer de l'œsophage, un trou de déglutition, un amaigrissement important dans ce contexte-là, une anémie par saignement. Donc, ça c'est pour les questions, les premières questions, on va passer à d'autres questions.

(32:45 - 33:25)

Il est quelle heure ? On a encore le temps. Alors, je pense que je vous ai fait hier le cours d'hypertension portale, je vais le voir avec vous. Donc, je vous ai fait l'hypertension portale hier,

je vais vous expliquer ce qu'il en était, et puis, c'est important de connaître la physiopathologie, et je vous ai donné les étiologies des hypertensions portales.

(33:25 - 33:55)

Parmi les étiologies des hypertensions portales, on a le bloc intrahépatique, le bloc infrahépatique et le bloc suprahépatique. Le bloc infrahépatique, c'est important, c'est le bloc sous-hépatique, ou bien préhépatique. Donc, trois choses que vous allez trouver dans beaucoup de livres, et ce n'est pas compliqué, ce n'est pas beaucoup de dénominations, il faut juste définir le foie et voir ce qu'il y a avant le foie, ce qu'il y a après le foie.

(33:55 - 34:12)

Ce qu'il y a avant le foie, il y a le système porte, il y a la veine porte. Donc, tout ce qui est avant le foie, puisque 70% du sang qui vient au foie sera donné par le système porte. Ce qui est avant le foie, c'est ce qui est sous-hépatique, ou bien dit aussi préhépatique, ou bien infrahépatique.

(34:12 - 34:40)

Et les principales étiologies de l'hypertension portale, des choses qui bloquent à ce niveau-là, sont soit une compression extrinsèque de la veine porte, soit un envahissement de la veine porte, soit une thrombose, soit des malformations congénitales. Après, il y a tout ce qui est hypertension portale par bloc intrahépatique. Et là, l'étiologie la plus importante, c'est la cirrhose, avec la principale étiologie de la cirrhose elle-même, c'est l'alcool, et ce sont les hépatites virales.

(34:40 - 34:51)

Après, les autres étiologies de la cirrhose, qui sont ce qu'on a dit tout à l'heure, biliaires, auto-immunes, et les maladies de surcharge. Donc, en principe, tout est écrit. Bilières, auto-immunes, hémochromatose, et maladies de Wilson.

(34:53 - 35:27)

Après, vous savez, quand je vous parlerai, quand vous trouverez dans le cours bloc suprahépatique, ça veut dire post-hépatique, puisque le flux vient par la veine portant le foie et qu'il va après, au niveau des cavités cardiaques, par les veines susses hépatiques, via la veine 4. Et dans ce cas-là, l'étiologie la plus fréquente, c'est le syndrome de Budd-Chiari. Vous allez le voir aussi, ce n'est pas barbare, c'est toute obstruction au niveau des voies veineuses, de retour veineux hépatique. Donc, très simplement, l'hypertension portale peut se manifester par les complications.

(35:28 - 36:14)

Vous avez la circulation collatérale, vous avez l'ascite, vous avez la splénomégalie et la

splénomégalie, quand elle est importante, elle va commencer à manger du fait de l'hypersplénisme des lignées et votre patient va avoir ce qu'on appelle une thrombopénie, diminution des plaquettes, parce qu'il y a une destruction, une séquestration au niveau de la rate et bien sûr, une diminution des globules blancs et voilà, une pancytopénie. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, est-ce qu'un cancer de l'oesophage va causer une dyspésie ? Bonne question. Je reviens, comme toujours.

(36:15 - 36:25)

Attendez une seconde. Alors, je reviens à ma définition de la dyspésie. Dyspésie, difficulté à digérer, ça c'est l'étymologie.

(36:26 - 37:09)

Après, c'est une douleur ou inconfort récidivant au niveau de la région épigastrique ou bien une douleur épigastrique ou bien un ballonnement de l'épigastre, une digestion lente, une satiété précoce. Oui, si le patient vient vous voir pour une douleur ou inconfort au niveau de la région épigastrique si on a un cancer du cardiaque, effectivement, ça peut prêter à tort, à une confusion avec la dyspésie. Donc, c'est quelque chose, la raison pour laquelle, si vous avez un trouble de déglutition ou une difficulté à avaler, il faut faire une fibroscopie pour faire la part des choses.

(37:10 - 37:36)

Parce qu'en fait, c'est vrai que le terme dyspésie vient de difficulté à digérer, mais la définition qui est donnée, c'est la suivante. Ensemble de symptômes, une douleur ou un inconfort chronique ou récidivant de la région épigastrique provenant du tractus digestif O. Donc oui, le cancer de l'œsophage peut être une étiologie de ce trouble-là. C'est bon ? Revenez toujours.

(37:36 - 37:53)

Quand vous voulez voir la dyspésie, revenez à la définition. Si je dois vous conseiller quelque chose, c'est de bien vous rappeler la première plaque qui est la définition et vous rappelez les causes organiques et les causes fonctionnelles. C'est tout.

(37:54 - 38:04)

Organiques, fonctionnelles. Vous avez la définition, vous avez les critères de Rome, un ou plusieurs des symptômes. Donc un seul, j'arrive pour le syndrome buccari, un ou plusieurs des symptômes.

(38:04 - 38:18)

Les symptômes, les quatre symptômes, c'est la répression postprandiale, c'est la satiété précoce, c'est la douleur épigastrique et la brûlure épigastrique. Un cancer du cardiaque, vous avez tout

ça. Alors, la question, la question, pardon, excusez-moi, on y va doucement.

(38:18 - 38:29)

Alors, pour expliquer, la stratégie traitée et testée. C'est basique, c'est bête. Vous avez un sujet jeune, 22 ans, qui est bien pourtant, qui n'a pas maigri, qui est super bien.

(38:30 - 38:39)

Il vient vous voir et il a une satiété précoce. Ça ne l'embête pas trop. Et donc, ce patient-là vous dit qu'est-ce que je dois faire.

(38:41 - 38:56)

Donc, vous avez le choix entre deux choses. Soit vous l'explorez, mais vous vous dites, mon patient, il est bien, il est bien pourtant. Soit, la stratégie traitée et testée.

(38:56 - 39:11)

Ou bien traitée et testée. En première attention, je vais donner un traitement. Je vais donner un traitement.

(39:12 - 39:23)

Je vais voir comment ça va se passer. Si c'est une douleur qui est pseudo-ulcéreuse et que je donne des IPP et qu'il est bien. Sinon, dans ce cas-là, si ça ne marche pas, je vais tester.

(39:24 - 39:37)

C'est-à-dire que je vais aller plus loin dans les explorations. J'ai mis ça dans un arbre décisionnel à la fin. Et donc, la question était d'arrêter, surtout pour les gens qui prennent des AINES, des anti-inflammatoires stéroïdiens, arrêter les AINES.

(39:37 - 39:45)

Quand ce n'était pas efficace, on traitait pendant IPP pendant un mois. Et quand c'est une forme motrice, on donne des pro-kinétiques. Quand c'est efficace, c'est tant mieux.

(39:45 - 40:09)

Quand c'est inefficace, on peut, donc, bien sûr, tester le patient pour *helicobacter pylori* et traiter pour *helicobacter pylori*. Et on est dans un pays où l'*helicobacter pylori* est très fréquent. Donc, on teste le patient par les différents tests d'*helicobacter pylori*, soit par la fibroscopie et la recherche d'*helicobacter pylori*, soit par des tests non-invasifs.

(40:09 - 40:24)

Et on traite le patient parce que, pour nous, l'hélicobacter pylori peut être responsable de ses dyspepsies parce qu'il a occasionné la gastrite. Alors après, le syndrome de Butchery. Le syndrome de Butchery, basiquement, là aussi, c'est de la tuyauterie.

(40:24 - 40:33)

Imaginez qu'il y a une obstruction au niveau des veines suisses hépatiques. Alors, le foie, il reçoit 70% de son sang par la veine porte. Et tout ça est traité à l'intérieur du foie.

(40:33 - 40:51)

Puis, ce qui part du foie va par les veines suisses hépatiques. Imaginez qu'elles sont bloquées, ces veines suisses hépatiques. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du foie ? Ben, simplement, il va devenir gros parce que le sang va, va, va, va être, il va regorger de sang parce qu'il ne pourra pas l'évacuer.

(40:51 - 41:03)

Et donc, il va être gros, il va être douloureux. Il y aura, euh, donc, une hépatomégalie. Il y aura une destruction puisque c'est comme de la tuyauterie.

(41:03 - 41:09)

Tout ce qui ne va pas en aval va regurgiter en amont. Il y aura une destruction des hépatocytes. Donc, il y aura une cytolysse.

(41:09 - 41:27)

Et ce sont les signes d'un syndrome de butchery aiguë. C'est une cytolysse qui est très importante avec un gros foie qui est douloureux. A terme, si l'obstruction se fait petit à petit, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, il va se passer que ce foie va souffrir petit à petit et il y aura un tableau qui va ressembler à un tableau de cirrhose.

(41:28 - 41:50)

Donc, c'est pour ça qu'on différencie entre butchery aiguë ou le diagnostic criant c'est une douleur, c'est quelqu'un qui a une cytolysse importante, l'insuffisance hépatocellulaire. Pourquoi ? Parce que le sang régurgite et qu'il y a une destruction hépatocytaire. D'un butchery chronique qui ressemble en fait c'est d'ailleurs une étiologie de la cirrhose qui ressemble à de la cirrhose avec toutes les complications de la cirrhose, l'hypertension portale, etc.

(41:52 - 42:23)

Et c'est pour ça aussi que dans le diagnostic étiologique de la cirrhose quand je vous parle d'échographie, il faut demander au biologiste de toujours étudier la veine porte et le flux et aussi

les veines succépatiques. C'est bon ? Je pense que réfléchissez pour la prochaine fois parce qu'on va se voir après qu'on ait fini les cours. On va vous laisser peut-être un petit peu de temps pour voir un petit peu à la part des choses dans tous ces cours et on fera une autre séance d'échange.

(42:23 - 42:34)

Préparez des questions si vous en avez et donc je vous prépare d'autres QCM. Et en principe il n'y aura pas de problème. Je vous dis au revoir.

(42:34 - 42:37)

Merci pour votre présence et à la prochaine fois.